

סיכום מפגש מדיניות בנושא ביטוחי הסיעוד מיום 29.10.2004

משתתפים: צוות מרכז טאוב, עמיתי תוכנית המדיניות בבריאות במרכז טאוב, נציגים ממשרדי הבריאות, הרווחה, האוצר והמוסד לביטוח לאומי, מוזמנים נוספים מומחים בעולם ביטוחי הסיעוד.

הסיכום נכתב בהתאם למגוון הקולות שעלו בדיון. יש לציין כי הסיכום אינו משקף בהכרח את עמדת מרכז טאוב או כל אחד מהמשתתפים.

להלן עיקרי הדברים שעלו בדיון:

- א. הממשלה צריכה לשים לה למטרה לפעול לקידום חיים עצמאיים ולדחיית התלות בקרב אזרחים ותיקים ככל האפשר, ועל משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי לפעול לאורה של מטרה זו.
- ב. ישנו פער גדול בין הנתונים המצביעים על עלייה משמעותית במספר האזרחים הוותיקים המוגדרים סיעודיים ובין נתונים על מצב הבריאות של הקשישים בישראל, שלא החמיר בשנים האחרונות.
- ג. הגידול במספר מקבלי גמלת הסיעוד וההוצאה של הביטוח הלאומי על סיעוד בשנים האחרונות נבע ממגוון גורמים שלא ניתן למדוד את ההשפעה שלהם בנפרד: מעבר לגמלה בכסף, שינוי אופן הבחינה של רמת התלות, מעבר משלוש לשש רמות תלות, הגדלת סכום הקצבה, ביטול האפשרות של הורדת רמת התלות בעת בקשת החמרה, וכניסתן של חברות מיצוי הזכויות לתחום.
- ד. הגידול במספר הזכאים לתגמולי הביטוח הקבוצתי שבבעלות קופות החולים נבע מכמה גורמים: שינוי הגדרת מקרה הביטוח, יצירת קשר בין מבחן הזכאות של חברות הביטוח לזה של הביטוח הלאומי, עלייה במספר מקבלי גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, וכניסתן של חברות מיצוי הזכויות לתחום.
- ה. אף שמסתמנת מגמה של הגברת שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה והביטוח הלאומי בנושא הזקנה באופן כללי, עדיין אין די שיתוף פעולה בנושא בין משרד הבריאות ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בכל הנוגע לביטוחי הסיעוד הקבוצתיים שבבעלות קופות החולים.
- ו. לנוכח הגידול הניכר במספר התביעות בביטוחים הקבוצתיים לא ברור אם יש להם היתכנות כלכלית.
- ז. שינוי מהותי שיחזיר את היציבות לעולם ביטוחי הסיעוד מחייב נקיטת צעדים אמיצים ולא פופולריים מצד מקבלי ההחלטות, בעיקר בנושא הגדרת מקרה הסיעוד ואופן הבחינה שלו.
- ח. יש צורך בדיון המשך בנוגע למעבר לקבלת גמלה בכסף במקום שירותים בעין.

חלופות מדיניות שהוצעו בדיון:

1. מציאת פתרון מיידי לביטוח הסיעודי של מבטחי כללית שיבטיח את המשכיותו גם לאחר שנת 2024.
2. ביצוע תיקונים מיידיים בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים של קופות החולים לשם הבטחת יציבותם (לרבות סעיף ז').
3. בחינת חלופות של החלפת הביטוחים הסיעודיים של קופות החולים בביטוח חובה או בחיסכון חובה לסיעוד (או בחלופות דומות שאינן חובה). בעת בחינת החלופות יש להביא בחשבון סוגיות של אי-שוויון ונטל חלוקת המיסים במדינה.
4. שיפור הביטוח הסיעודי הציבורי באמצעות הגדלת המימון לרמות התלות הגבוהות על חשבון רמות התלות הנמוכות וקידום תוכניות למניעת הידרדרות תפקודית ברמות התלות הנמוכות.